

Bronchiolite du nourrisson

Question n°1: La bronchiolite aigue du nourrisson est:

- A. Diagnostiquée cliniquement avec preuve d'infection virale
- B. Une infection virale des voies aériennes supérieures
- C. Une cause de dyspnée obstructive expiratoire
- D. Une pathologie fréquente chez les nourrissons
- E. Souvent causée par *l'haemophilus influenzae*

Réponse :

Question n°2: Dans la bronchiolite aigue du nourrisson :

- A. Le rhinovirus est le principal agent pathogène
- B. La coinfection virale est très fréquente
- C. Les examens complémentaires sont systématiques
- D. La prévention repose seulement sur la vaccination
- E. Le tableau clinique habituel comporte deux phases

Réponse :

Question n°3: Les virus qui peuvent être responsables de la bronchiolite aigue sont :

- A. Le bocavirus
- B. La *Bordetella pertussis*
- C. Le virus respiratoire syncytial
- D. Le métapneumovirus
- E. Le *rhinovirus*

Réponse :

Question n°4: Dans le tableau clinique dans la bronchiolite aigue :

- A. La dyspnée est souvent précédée par une rhinite
- B. La dyspnée est d'installation brutale
- C. La fièvre est souvent maltolérée
- D. Les signes de luttés sont présents
- E. La présence de râles crépitants est un signe de sévérité

Réponse :

Question n°5: Les indications de la radiographie du thorax chez un nourrisson ayant une bronchiolite aigue sont :

- A. Devant un deuxième épisode de bronchiolite légère
- B. Systématique

- C. Devant des signes de sévérité
- D. Devant la suspicion d'une insuffisance cardiaque
- E. En cas de persistance des signes plus que 7 jours

Réponse :

Question n°6 : Les examens complémentaires à demander devant une bronchiolite sévère avec fièvre à 38,7°C chez un nourrisson âgé de 4 mois sont :

- A. Une recherche virale
- B. Des hémocultures
- C. Une Radiographie de thorax
- D. Une échographie cardiaque
- E. Des Gaz du sang

Réponse :

Question n°7: Les signes radiologiques à rechercher dans une bronchiolite sévère sans fièvre sont :

- A. Un cœur de petit volume
- B. Des opacités pulmonaires bilatérales
- C. Une distension thoracique bilatérale
- D. Une atéléctasie
- E. Un élargissement médiastinal

Réponse :

Question n°8: Le tableau clinique d'une bronchiolite sévère chez un nourrisson âgé de 1 mois comporte :

- A. Une SatO₂ à l'air ambiant 90%
- B. Une Fréquence respiratoire à 57C/mn
- C. Une prise des tétés > 50% des apports
- D. Une déshydratation
- E. Des râles sibilants diffus aux deux champs pulmonaires

Réponse :

Question n°9: La gravité d'une bronchiolite est liée à :

- A. L'âge de moins de 3 mois
- B. Les antécédents de ventilation néonatale
- C. La récurrence de la bronchiolite
- D. La présence d'un contact viral
- E. L'incapacité des parents de surveiller leur enfant

Réponse :

Question n°10: Le tableau clinique d'une bronchiolite aigue légère comporte :

- A. Une Fréquence respiratoire à 60c/mn
- B. Des signes de lutttes respiratoires modérés
- C. Un refus alimentaire avec détresse respiratoire
- D. Une Saturation d'oxygène à 93%
- E. Des pauses respiratoires

Réponse

Question n°11: Les indications d'une hospitalisation d'une bronchiolite aigue du nourrisson sont :

- A. La saturation d'O2 à 92% à l'AA
- B. La présence d'atélectasie à la radiographie
- C. L'âge à 5 semaines
- D. La fréquence respiratoire à 58C/mn
- E. La présence d'un déficit immunitaire

Réponse :

Question n°12: Les diagnostics différentiels d'une bronchiolite aigue sont :

- A. La mucoviscidose
- B. La coqueluche
- C. L'asthme
- D. La myocardite aigue virale
- E. Le corps étranger intra-bronchique

Réponse :

Question n°13: La prise en charge d'une bronchiolite aigue légère repose sur :

- A. Le couchage proclive à 30°
- B. Une oxygénothérapie si satO2<92%
- C. La désobstruction rhino-pharyngée
- D. Une corticothérapie orale
- E. Un antipyrétique si température à 38°C

Réponse :

Question n°14: La prise en charge d'une bronchiolite aigue peut nécessiter :

- A. Une oxygénothérapie avec des lunettes à haut débit
- B. Une antibiothérapie si otite moyenne associée
- C. Une Kinésithérapie respiratoire
- D. Des corticoïdes par voie IV systématiques
- E. Un fractionnement des tétés

Réponse :

Question n°15: Les mesures symptomatiques dans la prise en charge de la bronchiolite sont :

- A. La désobstruction rhino-pharyngée
- B. L'information des parents des signes d'aggravation
- C. La kinésithérapie respiratoire
- D. L'aération de la chambre avec température ambiante à 20°
- E. L'interdiction du tabagisme passif

Réponse :

Question n°16: Dans la bronchiolite aigue, les parents doivent reconsulter si leur bébé présente :

- A. Une obstruction nasale
- B. Une diarrhée
- C. Une température à 38°C
- D. Un léger tirage sous costal
- E. Une difficulté de prise de tétées

Réponse :

Question n°17: Les complications chroniques d'une bronchiolite sont :

- A. Une insuffisance respiratoire aigue
- B. Une déshydratation aigue
- C. Un pneumomédiastin
- D. Un asthme viro-induit
- E. Une surinfection bactérienne

Réponse :

Question n°18: Les moyens de prévention de la bronchiolite aigue sont :

- A. De prolonger l'allaitement maternel
- B. De proscrire le tabagisme passif
- C. La mise en collectivité précoce
- D. Le port de masque pour les personnes contact
- E. La vaccination de la femme enceinte par VRSpreF

Réponse :

Question n°19: Le Nirsevimab est :

- A. Un anticorps monoclonal à demi-vie prolongée

- B. Administré tous les mois à partir de la naissance
- C. Indiqué chez les nouveaux nés, nés en saison de circulation de VRS
- D. Indiqué chez la femme enceinte entre le 32eme et 36eme SG
- E. Administré par voie IM

Réponse :

Cas Clinique :

Nourrisson..âgé de 2mois 10js, consulte le 03 octobre pour premier épisode de dyspnée évoluant depuis 24h. Il est née prématuré à 34SA avec PN= 2kg100. Il a été hospitalisé en néonatalogie pendant 1semaine. Actuellement, il est gardé par sa grand-mère avec ses cousins et il est sous allaitement mixte avec prise alimentaire>50%.

A l'examen : Poids= 4,2kg, température à 38,4°C, FR=65C/mn, FC=100batt/mn, présence de signes de luttres respiratoire (tirage sous-costal) avec des râles sibilants aux deux champs pulmonaires. Saturation d'O2 à 92% à l'air ambiant.

Question 1 : Quels sont les éléments cliniques en faveur du diagnostic positif de bronchiolite du nourrisson ?

- A. L'âge du nourrisson
- B. Les antécédents néonataux
- C. Le premier épisode de dyspnée sifflante
- D. Les signes de luttres respiratoires
- E. La saturation d'oxygène à 92%

Réponse :

Question n°2 : La bronchiolite chez notre patient est modérée devant :

- A. La FR à 65C/mn
- B. La fièvre à 38,4°C
- C. La SatO2 à 92%
- D. Les Râles sibilants
- E. La prise alimentaire >50% des apports

Réponse :

Question n°3 : Vous avez indiqué l'hospitalisation du nourrisson devant :

- A. L'âge du nourrisson
- B. La fréquence respiratoire à 65C/mn
- C. Les râles sibilants diffus
- D. La SatO2 à 92%
- E. La prématurité à 34SA

Réponse :

Question n°4 : la prise en charge thérapeutique chez notre patiente est :

- A. Des nébulisations de sérum hypertonique
- B. Désobstruction rhinopharyngée (DRP)
- C. Une antibiothérapie
- D. Fractionnement des tétées
- E. Une oxygénothérapie

Réponse :

Question n°5 : Le patient était en contact avec un cousin âgé de 1mois. Vous avez conseillé pour le cousin:

- A. De lui administrer le Nirsevimab
- B. D'encourager l'allaitement maternel
- C. D'éviter le contact avec notre patient en période d'épidémie
- D. Le port de masque par les personnes en contact
- E. De l'hospitaliser pour surveillance

Réponse :